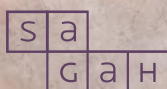


GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE

Karen Cardoso



SOLUÇÕES
EDUCACIONAIS
INTEGRADAS



Gestão de equipes nos serviços de saúde

Objetivos de aprendizagem

Ao final deste texto, você deve apresentar os seguintes aprendizados:

- Reconhecer a importância do trabalho em equipe no contexto atual das organizações de saúde.
- Definir as principais características de uma equipe eficaz.
- Identificar o papel do gestor no trabalho em equipe.

Introdução

A eficácia de uma equipe depende essencialmente de sua composição, de suas características e competências para alcançar as metas de trabalho propostas. Assim, o papel do gestor é, sem dúvida, fundamental para auxiliar a equipe a desenvolver todo o seu potencial e alcançar as metas propostas pelo estabelecimento de saúde. Portanto, conhecer e compreender o significado da equipe no contexto hospitalar é fundamental para depreender a importância do papel do gestor.

Neste capítulo, então, você vai conhecer o que caracteriza uma equipe, seu conceito e composição, bem como as implicações da equipe no contexto de trabalho em saúde. Nesse sentido, o contexto hospitalar altamente especializado e complexo traz consigo a necessidade evidente de diferentes tipos de competências, de modo a atender as inúmeras necessidades desse serviço. Por isso, você também vai conhecer a figura e o papel do gestor nesse contexto.

1 Trabalho em equipe nas organizações de saúde

O trabalho em equipe nas organizações de saúde vem adquirindo importância crescente devido à ampliação do entendimento de conceitos de trabalho em saúde, integralidade, trabalho colaborativo e equipe multidisciplinar.

A **integralidade** é um dos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) brasileiro e representa as ações que devem ser articuladas entre si e os serviços de atendimento ao usuário do SUS, tendo como foco todas as etapas para obter e manter a saúde, isto é, ações com o objetivo de promover, prevenir, fazer o diagnóstico precoce, disponibilizar tratamento e reabilitação conforme a necessidade do usuário e contemplando todos os níveis de complexidade das unidades do sistema (BRASIL,1990).

Nesse sentido, com o passar do tempo e a evolução do significado do cuidado em saúde do indivíduo, sua família e da população em geral, a Organização Mundial da Saúde (OMS) sinalizou a necessidade de atender as pessoas em suas diversas necessidades, indicando a equipe multidisciplinar como aquela que teria melhores condições de suprir essas demandas. De acordo com Peduzzi (2018), a esse cenário colaborativo e de integração entre os diferentes profissionais de saúde em uma equipe, adiciona-se a necessidade de integração entre equipes e serviços com o objetivo de alcançar maior dimensão da integralidade no atendimento ao usuário do sistema de saúde.

Embora a tendência de fragmentação da assistência e especialização seja uma realidade devido à velocidade da tecnologia e à necessidade de cada área profissional aprofundar seu conhecimento, a integralização da assistência em saúde aponta a incapacidade de que apenas um profissional dê conta do conjunto de demandas que os pacientes do sistema de saúde apresentam (PEDUZZI, 2018).

Dessa forma, o próprio processo de trabalho em saúde precisou ser revisitado, repensado, e o trabalho em equipe, principalmente da equipe multidisciplinar, ganhou força nas instituições como forma de atender a demanda crescente da visão de integralidade da assistência e do atendimento com foco no paciente.

Mas o que é uma equipe? Para Peduzzi (2016, documento *on-line*), a equipe é uma “[...] estratégia para a integração das especialidades e das múltiplas profissões, imprescindível para o desenvolvimento da assistência e do cuidado integral do paciente”. Assim, a equipe não é apenas um grupo de pessoas que trabalha no mesmo horário e departamento, mas um grupo que compartilha metas e objetivos e busca e compartilha soluções em comum, estabelecendo uma relação, que, no contexto hospitalar, tem como foco o usuário.

Sendo uma estratégia que tem como base de ação a colaboração, cabe conhecer o que significa esse conceito no contexto do trabalho em equipe. Segundo Fonseca (2018, documento *on-line*):

Colaboração é quando dois ou mais profissionais de saúde atuam de forma interativa, compartilhando objetivos, reconhecendo o papel e importância do outro na complementaridade dos atos em saúde. Essa compreensão expõe a necessidade de horizontalizar relações, questionando a histórica hierarquia entre os profissionais e entre estes e os usuários.

Para Mosser e Begun (2015), a equipe tem grande importância para as empresas, há diferenças entre as equipes em instituições de saúde de outros tipos de estabelecimentos. Muitas vezes, o grupo de empregados de uma empresa é entendido como parte de uma “equipe” — se consideramos que todos trabalham para uma mesma empresa e são colegas, é possível concordar com essa visão. No entanto, membros de uma equipe não dividem apenas um espaço de trabalho, mas têm objetivos em comum, assumem a responsabilidade como grupo, inclusive nos insucessos de seus esforços, ao cuidar de usuários de saúde, por exemplo. No entanto, no contexto da assistência em saúde, considera-se como equipe o grupo limitado de pessoas que varia em número entre 10 e 25 pessoas e que interage diretamente com o paciente e sua família. A composição pode variar conforme o perfil do serviço e do usuário, mas a questão central de uma equipe em um contexto de saúde é estar trabalhando e direcionando esforços para dar assistência ao paciente e sua família.

O modelo de assistência e o modelo de equipe

No modelo de assistência convencional, o atendimento do usuário ocorria apenas com o profissional médico, ficando opcional que outros profissionais especialistas estivessem envolvidos no processo. O que ocorre quando o trabalho é em equipe é que o foco se encontra no processo colaborativo e, assim, outros profissionais estão obrigatoriamente envolvidos na assistência ao paciente e sua família, conforme a necessidade de cada caso. Nesse modelo colaborativo, além do médico, há os profissionais especialistas em determinada área e o gestor da equipe, que lidera o processo (MOSSER; BEGUN, 2015).

Um bom exemplo para compreender os diferentes modelos é o atendimento a um paciente hipertenso. No modelo convencional, o paciente é tratado apenas pelo médico, que faz todo o direcionamento do tratamento e acompanhamento do caso. No modelo colaborativo, utilizando a equipe como ferramenta da

assistência integral, o **médico** atua na sua especialidade, fazendo o diagnóstico e a prescrição de medicamentos e exames necessários; o **enfermeiro** e o **técnico de enfermagem** fazem o acompanhamento do autocuidado e da mudança de hábitos de saúde, bem como monitoram a pressão do paciente e a adesão medicamentosa; o **nutricionista** verifica os hábitos alimentares e a dieta; o **psicólogo** verifica alterações no comportamento para enfrentamento da doença; o **educador físico** observa a condição física do paciente e orienta as atividades físicas adequadas; e o **assistente social** analisa as condições sociais da família e a inter-relação com o quadro de hipertensão.

Dessa forma, o trabalho em equipe no contexto dos estabelecimentos de saúde é fundamental para propiciar um atendimento ao usuário seguindo o princípio da integralidade e compreendendo que a soma e a união das especialidades e competências individuais a serviço da equipe podem multiplicar os recursos humanos em uma instituição de saúde.

A equipe e seus benefícios e riscos

Dentre os principais benefícios do trabalho em equipe, está a soma da experiência e do conhecimento dos seus componentes a serviço de objetivos em comum, levando em consideração que a união desse conjunto tem a possibilidade de atender as necessidades do usuário de forma mais plena. Dentre outros benefícios, estão a agilidade no desempenho de tarefas com economia de tempo e recursos, a capacidade de crescimento e desenvolvimento de seus componentes, com produção e retenção de conhecimento e rotinas eficientes testadas pelo grupo, capacidade de inovação perante novos desafios e compartilhamento de experiências (MOSSER; BEGUN, 2015).

O aprendizado não se restringe apenas à equipe em si, mas circula entre o gestor e a instituição de saúde, enriquecendo o ambiente organizacional como um todo. No entanto, os riscos também estão presentes no trabalho em equipe, como, por exemplo, a “ociosidade social”, isto é, a observação passiva de outros membros da equipe enquanto um dos membros, que muitas vezes é mais apto, está desenvolvendo um trabalho ou atividade. A ociosidade social pode ocorrer principalmente em equipes maiores, em que o comprometimento e a união não são desenvolvidos com frequência, e a tarefa acaba por recair sobre o membro mais ágil e competente (MOSSER; BEGUN, 2015). Nesse sentido, perde-se também a oportunidade preciosa de aprendizado entre os componentes da equipe e a transmissão do conhecimento.

Outro risco que pode ocorrer em uma equipe é o conflito de personalidades ou a personalidade dominante, que acaba por intimidar os outros componentes da equipe de forma que não se sentem à vontade de expressar dúvidas, opiniões ou sugestões que poderiam melhorar a *performance* da equipe e evitar erros e acidentes. Um exemplo é o médico com personalidade forte que comete um erro na prescrição de um medicamento ou procedimento, de forma que o enfermeiro se sente intimidado para questionar sua conduta — o excesso de hierarquia em uma equipe pode comprometer o processo de tomada de decisão (MOSSER; BEGUN, 2015).

Da mesma forma, a inovação e a criatividade podem ser menores por receio do profissional de expor as ideias ao grupo e não obter aprovação. Além disso, caso não haja respeito e igualdade nas relações, a ideia ou solução, mesmo que seja apropriada, pode ser bloqueada pelo grupo.



Fique atento

Segundo Braga (2011), os seguintes fatores podem comprometer o trabalho em equipe:

- baixa motivação dos servidores;
- equipamentos de informática obsoletos;
- espaços físicos inadequados para o desenvolvimento das atividades;
- número insuficiente de servidores nas unidades;
- procedimentos operacionais burocráticos e sem padronização;
- plano de cargos, carreiras e salários vigente inadequado;
- clima organizacional desfavorável à inovação e criatividade;
- pouco investimento em programas de qualidade de vida para servidores;
- baixa valorização dos servidores, com consequente falta de reconhecimento da sua capacitação;
- atitude e comportamento das chefias desfavorável ao clima organizacional;
- ausência de plano de saúde.

As equipes e os diferentes níveis de colaboração

A percepção do nível de colaboração das ações da equipe define o sucesso em determinar o foco no paciente e em suas necessidades, e não nos procedimentos técnicos em si, evitando a interposição de ações profissionais e proporcionando a articulação:

A necessidade de articular as ações dos diferentes profissionais, estabelecendo uma colaboração entre eles, requer a busca do entendimento, o reconhecimento de suas diferenças e dos benefícios da articulação para a atenção às necessidades de saúde, o que, por sua vez, favorece o deslocamento da ação profissional do foco nos procedimentos para o foco no paciente/usuário e, portanto, para a interação profissional-usuário e entre os profissionais (PEDUZZI, 2016, documento *on-line*).

Para que o foco siga no paciente e na colaboração entre os diferentes profissionais, é necessário compreender que há diversos tipos de equipe, não sendo possível definir um conceito genérico e superficial. Diferente da equipe multiprofissional, em que há diversos profissionais atuando, sem obrigatoriamente integração ou inter-relação, a equipe interprofissional se caracteriza por inter-relação entre os profissionais e pela colaboração como processo. Dessa forma, Peduzzi (2016) distingue diferentes tipos de equipe, observando que a mera justaposição ou o agrupamento de diferentes profissionais atendendo a um mesmo paciente não configura uma equipe efetiva com resultados positivos aos pacientes. Esse tipo inicial de processo é definido com **pseudoequipes**, **equipes fragmentadas**, **equipes de agrupamento**, todas com um grande potencial para a colaboração, mas sem ações de colaboração ativas em sua totalidade.

Em uma fase seguinte do processo, a **pseudoequipe** ou **equipe de semi-integração**, é caracterizada pela transição do foco em interesses individuais e atuação profissional semiestruturada, com a colaboração em desenvolvimento, com foco na organização da assistência, mas ainda com foco profissional. Finalmente, a **equipe integrada** se caracteriza por articulação das ações entre os diferentes profissionais, interdependência e responsabilização das ações, e os objetivos em comum têm foco no paciente. Essas equipes podem ser consideradas **equipes interprofissionais integradas com foco no usuário/paciente**.

Nesse sentido, de acordo com Peduzzi (2016, documento *on-line*), as **equipes interprofissionais integradas** “[...] são aquelas capazes de assegurar efetiva comunicação, articulação das ações e colaboração entre os profissionais das diversas equipes do serviço e entre os profissionais e equipes de diferentes serviços da rede” e que envolvem o núcleo das competências profissionais. Esse núcleo, por sua vez, inclui o “[...] campo como conhecimentos, habilidades e atitudes comuns e compartilhadas pelas diferentes áreas profissionais da saúde, e núcleo profissional como aquele que envolve as competências específicas de cada profissão implicada no cuidado em saúde” (PEDUZZI, 2016, documento *on-line*).

Ao desenvolver e fortalecer as diferentes competências dos profissionais de saúde, proporcionar um sistema administrativo ágil e desburocratizado e um clima organizacional de confiança e respeito, o gestor e a instituição estimulam o desenvolvimento de equipes interprofissionais integradas, focadas na assistência ao paciente. Assim, a equipe e seus componentes se conectam com a integralidade e seus significados entre o **eixo das necessidades**, que compreende atender além das necessidades orgânicas dos indivíduos; o **eixo das finalidades**, em que ocorre de forma integrada a promoção, a prevenção e a recuperação da saúde; o **eixo das articulações**, que envolve ações de interdisciplinares, intersetoriais e interprofissionais necessárias à qualidade e melhores práticas e condições de saúde; e o **eixo das interações**, que inclui aspectos subjetivos da interação entre as pessoas e que são responsáveis por melhorar as condições na atenção à saúde (PEDUZZI, 2016).

2 Eficácia das equipes de saúde

As equipes têm características diferentes, mas uma das mais almejadas é a eficácia. A equipe eficaz é aquela que consegue obter os melhores resultados na assistência ao paciente e sua família, alcançando suas metas e propondo novos desafios e patamares de excelência. A integração entre os componentes da equipe é fundamental para que isso ocorra e, nesse sentido, a equipe eficaz tem um conjunto de características que concorrem para que essa integração ocorra:

Comunicação efetiva; reconhecer o trabalho do(s) outro(s) profissional(s), suas especificidades; questionar a desigualdade na valoração dos distintos trabalhos e respectivos agentes; construir objetivos comuns; promover a tomada de decisão compartilhada, exercer autonomia profissional tomando em consideração a interdependência das diversas áreas e construir um projeto assistencial comum (PEDUZZI, 2014, documento *on-line*).

Embora a flexibilização da divisão do trabalho possa ocorrer, há necessidade de estabelecer limites de atuação principalmente para desenvolver ações em comum. Os limites se mostram necessários, pois é preciso preservar as ações específicas de cada área profissional.

A comunicação efetiva, com base no respeito e na capacidade de todos os componentes da equipe em executar sua parte no atendimento ao usuário, é uma das características que consolidam a integração das equipes eficazes. A comunicação e a interação entre os membros da equipe podem auxiliar na

mediação de conflitos, na elaboração de acordos, consensos e rotinas que, mesmo que provisoriamente instituídos, servem como ponte relacional e apontam soluções no processo de trabalho, evitando atritos e promovendo maior integração. Nesse sentido, as equipes podem ter um estilo de trabalho derivado de um projeto assistencial em comum e pactuado entre os componentes (PEDUZZI, 2016).

No entanto, outras características são necessárias para que essa eficácia seja direcionada ao alcance de objetivos e metas comuns, conforme você confere no Quadro 1, a seguir.

Quadro 1. Características de uma equipe eficaz

Característica	Definição
Meta da equipe compartilhada	Os membros de uma equipe trabalham com objetivos compartilhados, buscando alcançá-los em esforços comuns.
Responsabilidade compartilhada para alcançar o objetivo	Os créditos de sucesso são divididos com os membros da equipe, bem como o seu insucesso. Bons resultados e a responsabilidade dos erros são compartilhados.
Quadro pessoal definido	A composição do número de membros é limitada, variando entre 10 e 25.
Autoridade de ação para alcançar o objetivo	A equipe tem autonomia interna para tomar as decisões necessárias para alcançar suas metas.
Interdependência dos membros	Os membros dependem uns dos outros para executar diversas e diferentes partes do trabalho.
Ausência de subgrupos independentes	A equipe deve formar uma unidade sem subdivisões.
Prestação de contas à organização	A equipe necessita prestar contas de suas atividades à organização mantenedora.

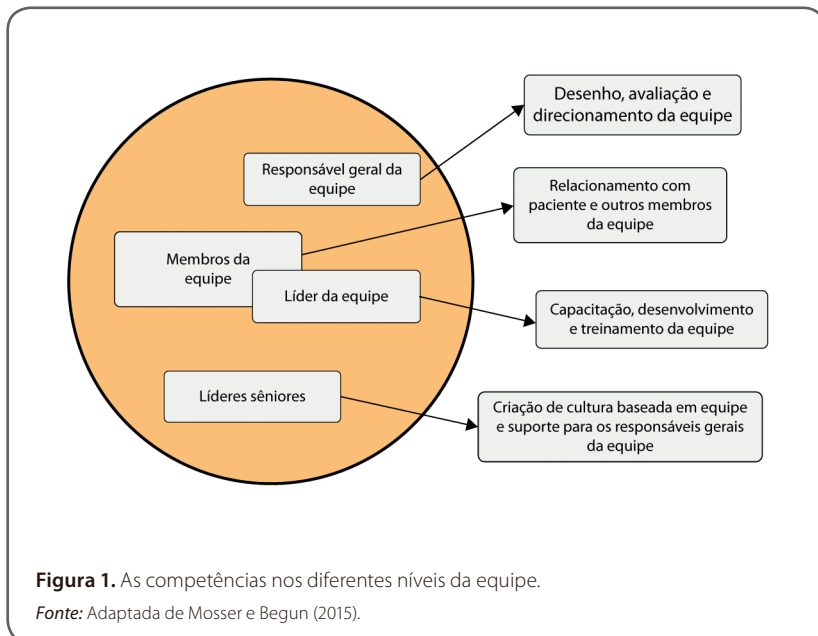
Fonte: Adaptado de Mosser e Begun (2015).

As competências da equipe do estabelecimento de saúde

Quais seriam as competências que equipes necessitam para desenvolver suas atividades no estabelecimento de saúde? Essas competências abrangem o conhecimento específico das suas áreas de atuação, mas não apenas esse. Ao conhecimento específico é somado um conjunto de valores éticos e relacionais que são importantes para o sucesso da equipe e para o exercício profissional.

A competência também pode ser compreendida como uma mescla entre o conhecimento necessário imprescindível, um conhecimento especializado e valores: “Assim, podemos entender uma competência como uma habilidade necessária para o desempenho de uma função específica, ou como o conhecimento em um domínio particular, ou um valor que pode ser expresso em ação, ou alguma combinação dos três” (MOSSER; BEGUN, 2015, p. 11).

Essas competências necessitam permear de diferentes formas o gestor e cada componente da equipe, além do gestor do estabelecimento de saúde. Para Mosser e Begun (2015), as competências são necessárias em quatro níveis diferentes, conforme mostra a Figura 1.



Assim, é importante que você perceba que os gestores das equipes também devem desenvolver competências que o ajudem a apoiar a equipe e exercer sua liderança, o que é fundamental para que tenha sucesso como gestor.

As equipes de alto desempenho

As equipes de alto desempenho são aquelas que têm conhecimentos complementares, mantendo um profundo compromisso com as metas e os objetivos do grupo. O nível do compromisso com o sucesso e o crescimento uns dos outros é muito maior do que em outras equipes, o que eleva o desempenho consideravelmente. Dessa forma, os níveis de desempenho estão extremamente acima de outras equipes, pois o comprometimento com o sucesso de cada membro da equipe é muito maior (ROCHA; ZERMIANI, 2017).

O fator relacional que envolve o compromisso com o sucesso do outro tanto quanto com o seu próprio é uma das características das equipes de alto desempenho, pois esse tipo de compromisso supre eventuais deficiências que um dos membros da equipe tenha, mas que, ao ser apoiado pelo grupo, consegue executar a tarefa e superar a expectativa.

De acordo com Rocha (2017), outra característica de equipes de alto desempenho é o estabelecimento de objetivos elevados, que sejam desafiadores o suficiente para estimular as pessoas e a equipe a se superarem. Esses objetivos alcançáveis devem ser formulados dentro da equipe, em que as estratégias e ações são pactuadas e planejadas em conjunto, dividindo em decisões e ações para alcançar objetivos imediatos, em médio prazo e em prazos maiores — de modo que a motivação da equipe é mantida elevada.

O atendimento de outras necessidades, como aceitação, afeto e controle, também está presente nas equipes de alta performance. Nesse sentido, a necessidade de ser aceito, notado, ser diferente e ter controle é uma característica humana normal e esperada nas pessoas, o que, em alguns grupos, pode virar uma fraqueza e levar a disputas, mas, em equipes de alto desempenho, é um fator para fortalecimento e união (ROCHA; ZERMIANI, 2017).

A criação de vínculos emocionais também é um diferencial nas equipes de alto desempenho e que se caracterizam por relações mais verdadeiras, com comunicação efetiva, maior *feedback* e respeito às normas de relacionamento humano.

Mas qual é o impacto das equipes nas instituições? Levando em consideração que o capital humano é uma ferramenta que desenvolve e aperfeiçoa os serviços prestados, não é de se admirar que o desenvolvimento dos indivíduos deve ir além da preparação para as atividades laborais, mas necessita de um senso de propósito e de valor:

Quando a empresa acredita no potencial de cada membro de sua equipe, dá um sentido maior para a realização do trabalho, ou seja, instruir e capacitar geram ideias e desafios motivadores. As organizações que criam desafios para os colaboradores, os incentivam a terem boas ideias e faz com que tornem os produtos melhores. Isso é mais do que instruí-los (FONSECA, 2018, documento *on-line*).

Dessa forma, a motivação leva a equipe e seus componentes a quererem desenvolver o trabalho e alcançar os objetivos e metas. Nesse sentido, as empresas inovadoras estimulam e incentivam as equipes e seus colaboradores a desenvolver ideias que aperfeiçoem serviços e produtos (FONSECA, 2018).

Pode parecer complexo desenvolver todas essas características em uma equipe e orientá-la para que seja eficaz no processo de trabalho, mas o gestor de equipes nos serviços de saúde deve preparar-se e desenvolver as competências gerenciais necessárias para cumprir o seu papel na equipe.

3 O papel do gestor no trabalho em equipe

A estrutura convencional das instituições e dos estabelecimentos de saúde traz consigo o peso da burocracia e a organização desconectada entre a gestão administrativa e a gestão clínica. Essa visão desarticulada não facilita o desenvolvimento de equipes eficazes e de alto rendimento. Para os profissionais de saúde, a burocracia é limitante às ações que envolvem a agilidade, a criatividade e a motivação no trabalho: “Aos olhos dos profissionais, as burocracias são organizações hierárquicas com incontáveis regras e políticas e controle centralizado pelo escalão superior na hierarquia. Muitas vezes, as burocracias são percebidas como impessoais, lentas e sufocantes” (MOSSER; BEGUN, 2015, p. 85).

Diferente da burocracia tradicional, a burocracia em estabelecimentos de saúde tem como foco o poder da excelência ao invés do poder da posição administrativa, buscando a manutenção dos padrões de qualidade e o cumprimento da chamada “burocracia profissional”, que envolvem colocar em prática diretrizes e protocolos que são desenvolvidos sem envolvimento da área administrativa em instituições representativas fora do estabelecimento de saúde ou por profissionais da própria instituição (MOSSER; BEGUN, 2015).

Assim, em instituições que têm uma burocracia profissional, um gestor tem um papel importante em direcionar as ações que são responsáveis por alcançar as metas e os objetivos dos serviços, como, por exemplo, “[...] planejamento estratégico, sistemas de informação, análise financeira, marketing, gestão de recursos humanos”, atuando como facilitadores da atividade fim (MOSSER; BEGUN, 2015, p. 86).

Nesse contexto, é importante compreender por que o papel do administrador ou gestor é tão importante para a equipe que presta assistência, independentemente de estar ou não inserido na equipe.

O gestor tem acesso a recursos aos quais, provavelmente a equipe, não terá se não houver uma relação coordenada entre equipe e gestor, pois, como mencionado, em várias instituições, a equipe é composta de profissionais clínicos especializados, que não absorvem como sua a dimensão administrativa do cuidado, focando na prática profissional específica.

Nesse sentido, segundo Mosser e Begun (2015, p. 92), os gestores são considerados as “[...] peças fundamentais na prestação de atendimento baseado em equipe” porque:

- possuem informação privilegiada e acesso a recursos financeiros e materiais que podem auxiliar as equipes a alcançar suas metas e objetivos;
- têm uma visão global da instituição, o que pode ser fundamental para o processo de tomada de decisão e planejamento;
- estabelecem conexões com outros atores externos à instituição e com outras equipes;
- têm acesso a outras instituições e canais de comunicação;
- podem contribuir com sua visão e experiência.

As competências do gestor da equipe

Segundo Peduzzi (2016), o gestor necessita ter competência para conseguir promover e manter a integração do trabalho em equipe. Para isso, precisa:

- conhecer a missão, os objetivos e a visão da instituição e ser capaz de compartilhar e articular com a equipe, de forma que essa equipe e a organização estejam alinhadas em propósito — é importante, também, conhecer e traduzir para a equipe a política organizacional;
- desenvolver a competência comunicacional de forma a traduzir e compartilhar informações, evitando a retenção e a paralisação do processo de tomada de decisão das equipes;
- compreender e articular conceitos e ideias complexas de forma simples e clara e compartilhá-los com a equipe, certificando-se de que a equipe consegue compreender e compartilhar os mesmos conceitos corretamente;
- ter habilidade de envolver suas ideias e conceitos em situações de diálogo, com capacidade de ouvir e verbalizar de forma articulada;
- promover o empoderamento da equipe e a sua autonomia, atribuindo responsabilidade e autoridade e fortalecendo suas ações na instituição.

Uma das características importantes a ser desenvolvida pelo gestor é a liderança. A partir do exercício da liderança na equipe, o desenvolvimento de uma equipe de alto rendimento e o direcionamento para o alcance dos objetivos da equipe e da assistência ao paciente são alcançados com mais facilidade.

Ser gestor *versus* ser líder

Um líder é uma pessoa que desenvolve, além das competências administrativas, competências relacionais e de comunicação:

É uma influência interpessoal exercida em uma dada situação e dirigida por meio do processo de comunicação humana para a consecução de um ou mais objetivos específicos. Os elementos que caracterizam são, portanto, quatro: a influência, a situação, o processo de comunicação e os objetivos a alcançar (CHIAVENATO, 2008, p. 112).

Nesse sentido, a liderança difere da gestão em foco e propósito que extrapola a simples tarefa e foca no direcionamento e apoio das pessoas e equipes. As diferenças envolvem o processo de trabalho e a forma como se desenvolve na instituição, assim como a influência interpessoal na equipe e nas pessoas.

Desse modo, as tarefas do líder são muitas, pois englobam ações de estruturação e definição de funções. A partir disso, e reconhecendo o potencial de competências das pessoas individualmente e da equipe como um todo, consegue “[...] distribuir funções, orientar, coordenar, controlar, motivar, elogiar, punir,

reforçar, contudo, o fundamental baseia-se no direcionar o grupo para metas específicas” (SILVA, 2019, documento *on-line*).

Diferente do gerente, que executa todas essas atividades com a lente da tarefa, o líder executa as tarefas administrativas levando em consideração outros aspectos, além do conhecimento específico, como, por exemplo, a motivação, o desenvolvimento de pessoas e a comunicação efetiva como ferramentas do exercício da liderança. Independentemente do estilo de liderança que adote, o gestor deve ter algumas características como líder (SILVA, 2019). Um dos seus grandes desafios está em descobrir o que realmente motiva indivíduos e equipes, mas cabe ao líder, por meio de conexão, comunicação e inteligência emocional que estabelece com o grupo, estar atento ao que move os indivíduos a alcançar as metas no trabalho.

A inteligência emocional envolve o equilíbrio das ações de relacionar-se com as pessoas e o ambiente, aumentando sua capacidade de decisão e resiliência às adversidades e diversas situações diárias que se apresentam. Essa inteligência depende do desenvolvimento de algumas competências, que, segundo Oliveira (2016), são fundamentais para exercer o papel de gestor líder.

- **Autoconsciência:** está relacionada com autopercepção, autoconhecimento, isto é, conhecer seus próprios sentimentos, que influenciam o seu desempenho e capacidade de avaliar-se e conhecer os seus limites, seus pontos fortes e fracos, bem como se desenvolver e buscar constante aperfeiçoamento. Também inclui a autoconfiança, isto é, a confiança em suas habilidades.
- **Autogestão:** relacionada à capacidade de compor alguns aspectos, como **autocontrole**, controlando as emoções e impulsividade, principalmente as emoções negativas direcionadas às ações úteis; **transparência**, que envolve a capacidade de expressar sentimento, crenças e ações a outras pessoas, de forma respeitosa e clara; **adaptabilidade**, ou seja, a capacidade de lidar com situações novas e problemas complexos sem perder o foco ou a capacidade de realização; **consecução**, que engloba a capacidade de buscar sempre o melhor desempenho para si e para sua equipe; **iniciativa**, isto é, perceber ou criar as oportunidades para desenvolvimento da equipe e alcance de metas da equipe; e **otimismo**, que é a capacidade de encontrar soluções mesmo em situações adversas.
- **Consciência social:** relacionada à capacidade do líder em desenvolver **empatia**, que é a capacidade de perceber os diferentes níveis e sinais emocionais das pessoas e das equipes, em diferentes contextos culturais, sociais e educacionais; e a **consciência organizacional**, ou seja, conhecimento e compreensão da política organizacional e tudo que pode influenciar o clima organizacional, relações de poder, relacionamento e satisfação do cliente.

- **Capacidade relacional:** referente ao uso de inteligência emocional nas relações de trabalho e composta de aspectos importantes, como **inspiração** — o uso do da motivação do grupo por meio do exemplo; **influência** — isto é, a capacidade de influenciar grupos e pessoas para determinada ideia ou direcionamento; e **desenvolvimento de pessoas** — interesse de ajudar outras pessoas no desenvolvimento de habilidades e do seu pleno potencial.

É, portanto, fundamental levar em consideração as diversas dimensões do desenvolvimento de equipes efetivas, as características necessárias para equipes eficazes e alto desempenho, bem como a importância do papel do gestor como facilitador e direcionador das ações da equipe, com foco sempre no paciente.



Exemplo

A senhora Maria de Fátima é hipertensa e tem uma arritmia leve. É diabética e tem 80 anos. Além disso, faz tratamento para glaucoma, sofre de depressão, vive sozinha e depende da pensão de aposentada para suas necessidades. Nesse contexto, a usuária em questão é avaliada pelo clínico geral e geriatra que faz o seu acompanhamento. Somado a ele, seguem-se outros especialistas, como o cardiologista, o endocrinologista, o oftalmologista, a psicóloga, a enfermeira, a técnica de enfermagem, a nutricionista e a assistente social. Nesse caso, há uma configuração tradicional, em que a idosa é atendida individualmente pelos profissionais citados, sem, no entanto, nenhuma interação, interdependência ou colaboração, risco de acompanhamento fracionado e em repetição ou ausência de verificação das suas reais necessidades.

Em um contexto da estratégia da saúde da família que faz parte das políticas de saúde do SUS, o caso de dona Maria de Fátima pode ser administrado com uma equipe integrada por: um agente de saúde, que faz a conexão da idosa com a Unidade Básica de Saúde; o clínico geral especialista em saúde da família, que monitora e acompanha as patologias existentes e encaminha a paciente ao especialista quando necessário; a enfermeira, que levantará as necessidades assistenciais e a adesão ao tratamento, como o uso correto dos medicamentos e o risco de lesões de pele e outros sinais e sintomas, bem como o monitoramento da pressão e outros sinais, auxiliada pela técnica de enfermagem; a nutricionista, que acompanha a adesão à dieta adequada; a assistente social, que acompanha todo o aspecto social e econômico da idosa que mora sozinha e seus vínculos de apoio; o educador físico, que se preocupa com a rotina de exercícios necessários, e a psicóloga, que observa o processo de depressão.

Esse é apenas um exemplo de um usuário comum no SUS. A equipe integrada se reúne semanalmente para analisar os casos como de dona Maria de Fátima, observando suas necessidades individuais, e traçar um plano de cuidados específico com base nos protocolos e políticas já formuladas. Sem a articulação dos profissionais, não é possível atender as necessidades de uma usuária como dona Maria de Fátima e mantê-la ao máximo com saúde.



Referências

BRAGA, A. A.; OLIVEIRA G. C.; SIENA, T. M. Fatores e aspectos que impactam o trabalho em equipe. *Revista de Administração e Negócios da Amazônia*, v. 3, nº. 3, set./dez. 2011. Disponível em: <http://www.periodicos.unir.br/index.php/rara/article/download/301/308>. Acesso em: 6 maio. 2020.

BRASIL. Lei nº. 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. *Diário Oficial da União*, Brasília, 20 set. 1990. Disponível em: http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/Lei%208.080-1990?OpenDocument. Acesso em: 6 maio 2020.

CHIAVENATO, I. *Administração geral e pública*. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.

FONSECA, R. M. da. *Educação interprofissional em saúde e o desenvolvimento de competências colaborativas na formação em enfermagem e medicina*. 2018. 70 f. Dissertação (Mestrado em Ensino na Saúde) — Centro de Ciências da Saúde, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2018. Disponível em: https://repositorio.ufrn.br/jspui/bitstream/123456789/25871/1/RedianneMedeirosDaFonseca_DISSERT.pdf. Acesso em: 6 maio 2020.

MOSSER, G.; BEGUN, J. W. *Compreendendo o trabalho em equipe na saúde*. Porto Alegre: AMGH, 2015

OLIVEIRA, R. de S. *O papel do gestor na maximização da produtividade no meio ambiente do trabalho*. 2016. 61 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Administração) — Fundação de Ensino Eurípides Soares da Rocha, Centro Universitário Eurípides de Marília, Marília, 2016. Disponível em: <https://aberto.univem.edu.br/bitstream/handle/11077/1556/TCC%20-%20O%20papel%20do%20gestor%20na%20maximiza%20a%7c3%a3o%20-%20CD%20Rafael%20de%20Souza%20466530.pdf?sequence=1>. Acesso em: 6 maio 2020.

PEDUZZI, M. et al. Trabalho em equipe, prática e educação interprofissional. In: MARTINS, M. de A. et al. (ed.). *Clínica médica: atuação da clínica médica, sinais e sintomas de natureza sistêmica, medicina preventiva, saúde da mulher, envelhecimento e geriatria*. São Paulo: Manole, 2016. p. 1–9. 1 v.

PEDUZZI, M.; AGRELI, H. F. Trabalho em equipe e prática colaborativa na atenção primária à saúde. *Revista Interface*, v. 22, Supl. 2, p. 1525–1534, 2018. Disponível em: <https://www.scielo.br/pdf/icse/v22s2/1807-5762-icse-22-s2-1525.pdf>. Acesso em: 6 maio 2020.

ROCHA, F.F.; ZERMIANI, J. A. *Os fatores contribuintes para produtividade de equipes multidisciplinares*. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso (Pós-graduação em Dinâmica dos grupos) — Sociedade Brasileira de Dinâmica de Grupos, Faculdades Monteiro Lobato, Joinville, 2017.

SILVA, P. M. S. e. *O papel do líder na motivação da equipe*. 2019. Disponível em: https://oswaldocruz.br/revista_academica/content/pdf/Pollyana_Mara_Silva_e_Silva.pdf. Acesso em: 6 maio 2020.

Leitura recomendada

HANSEN, M. T. *Sucesso no trabalho*: como os melhores gestores e funcionários trabalham menos e rendem mais. Rio de Janeiro: Rocco, 2019.



Fique atento

Os *links* para *sites da web* fornecidos neste capítulo foram todos testados, e seu funcionamento foi comprovado no momento da publicação do material. No entanto, a rede é extremamente dinâmica; suas páginas estão constantemente mudando de local e conteúdo. Assim, os editores declaram não ter qualquer responsabilidade sobre qualidade, precisão ou integralidade das informações referidas em tais *links*.

Encerra aqui o trecho do livro disponibilizado para esta Unidade de Aprendizagem. Na Biblioteca Virtual da Instituição, você encontra a obra na íntegra.

Conteúdo:



SOLUÇÕES
EDUCACIONAIS
INTEGRADAS